Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Cível da Comarca de Lajeado

Rua Paulo Frederico Schumacher, 77 - Bairro: Moinhos - CEP: 95900780 - Fone: (51) 3710-1500 - Email: frlajeado2vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5002411-83.2021.8.21.0017/RS

AUTOR: LIERE ROSA OLIVERIO

RÉU: UNIMED - COOPERATIVA DE SERVICOS DE SAUDE DOS VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA.

SENTENÇA

LIERE ROSA OLIVERIO ajuizou a presente **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA** em face de **UNIMED - COOPERATIVA DE SERVICOS DE SAUDE DOS VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA.**, todos qualificados, alegando que é filiada ao plano de saúde do réu, e que é portadora de Leucemia Mieloide Crônica - LMC, com classificação SOKAL de alto risco desde 2017. Disse que utilizou diversas medicações, mas que atualmente necessita inicial com a medicação Ponatinib (Iclusig) 15mg - 3 cápsulas ao dia, com urgência, para controle da doença, sem o qual a enfermidade pode evoluir para leucemia aguda, aumentando o risco de óbito, conforme atestado pela sua médica. Mencionou ter solicitado o medicamento administrativa, mas que foi negado sob o argumento de que o medicamento não possui cobertura obrigatória conforme rol da ANS. Requereu, assim, a concessão de tutela de urgência para determinar que a ré fornecesse o medicamento gratuitamente e, no mérito, a confirmação da tutela. Requereu AJG e juntou documentos.

Recebida a inicial, foi deferida a tutela de urgência e a AJG à autora (evento 3, DESPADEC1).

Na petição do evento 12, PET1 a demandada informou o cumprimento da liminar.

Citada, a ré contestou o feito (evento 15, CONT1), alegando que o fármaco não possui cobertura pelo plano de saúde contratado, bem como teceu acerca da taxatividade do rol de procedimentos publicados pela ANS. Requereu, assim, a improcedência do feito. Juntou documentos.

Houve réplica (evento 22, RÉPLICA1).

Intimadas as partes acerca das provas a serem produzidas no feito, a parte autora requereu a designação de audiência, com a oitiva da médica, enquanto a demandada juntou oficiamento à ANS. Posteriormente, a autora juntou aos autos laudo médico escrito apresentado pela médica.

Nada mais sendo requerido pelas partes, o feito veio concluso para julgamento.

É o relato.

Decido.

O processo transcorreu regularmente, não restando quaisquer eivas ou nulidades. Sem preliminares pendentes de análise, passo ao exame do mérito da causa.

Trata-se de ação que almeja a parte autora seja determinado ao réu o cumprimento de obrigação de fazer, consistente no fornecimento do medicamento ICLUSIG (Ponatinib) 15mg, conforme orientação médica, sendo necessárias 3 (três) caixas mensais para o correto enfrentamento de Leucemina Mieloide Crônica – LMC, com classificação SOKAL de alto risco.

Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Aliás, este é o entendimento da Súmula 608 do STJ[1].

Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

No caso em análise, resta incontroversa a contratação do plano de saúde (evento 15, CONTR2) bem como o diagnóstico de LMC e a recomendação médica para uso do medicamento Pontinib (Iclusig) 15 mg - 3 comprimidos ao dia (evento 1, LAUDO4).

De outro viés, a alegação da parte ré é de que o referido medicamento estaria excluído de cobertura para os tratamentos não elencados no rol de procedimentos da ANS.

No entanto, descabe a negativa. Isso porque o tratamento foi recomendado pela médica assistente da autora (evento 1, LAUDO4 e evento 64, LAUDO2), indicando que esta deve fazer uso contínuo de doses de Ponatinib (Iclusig) 15mg - 3 comprimidos ao dia, para controle da doença. Assim, considerando a indicação médica, necessária se mostra a cobertura do tratamento, pois se está a tratar de um bem de hierarquia superior que é a saúde humana.

Outrossim, além do princípio da boa-fé entre as partes, o plano ou seguro de saúde não pode, segundo o previsto no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, impor obrigações abusivas que coloquem o consumidor em manifesta desvantagem.

A propósito, um dos elementos essenciais do contrato de prestação de serviços médicos é a boa-fé entre os contratantes, prevista no art. 422 do Código Civil vigente2.

Além disso, o que importa é a existência de cobertura do contrato para a doença apresentada pela parte autora, não importando a forma como o tratamento será ministrado.

Nessa linha, os seguintes precedentes jurisprudenciais:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDE E MUTAÇÃO DO FATOR V DA PROTROMBINA. FORNECIMENTO DO FÁRMACO ENOXAPARINA. DEVER DE COBERTURA VERIFICADO. 1. INCIDE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE, SALVO OS ADMINISTRADOS POR ENTIDADES DE AUTOGESTÃO, CONSOANTE DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 3º, §2º, BEM COMO PELO QUE DISPÕE A SÚMULA Nº 608 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O ARTIGO 35 DA LEI Nº 9.656/1998. 2. AS COBERTURAS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS POR PLANOS DE SAÚDE SE SUJEITAM A UM ROL MÍNIMO EDITADO PELA ANS, O QUAL NÃO PODE PREVER AS HIPÓTESES DO ART. 10 DA LEI Nº 9.656/98 E NÃO PODE EXCLUIR OU MITIGAR AS HIPÓTESES DO ART. 12 DA MESMA LEI. NÃO OBSTANTE, EVIDENTEMENTE QUE OS CONTRATOS FIRMADOS PODEM ALARGAR O ESPECTRO MÍNIMO DE COBERTURA, INCLUSIVE COBRINDO AS HIPÓTESES DO CITADO ART. 10. 3. NO PONTO, CUMPRE DESTACAR QUE, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA C. CÂMARA CÍVEL, O ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE PUBLICADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR É TÃO SOMENTE REFERÊNCIA BÁSICA DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS NOS PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NÃO POSSUINDO CARÁTER TAXATIVO. 4. RESSALTE-SE, OUTROSSIM, QUE, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA C. CÂMARA CÍVEL, É FACULTADO AOS PLANOS DE SAÚDE ESTABELECEREM PARA QUAIS PATOLOGIAS IRÃO OFERECER COBERTURA; NO ENTANTO, NÃO PODEM LIMITAR O TRATAMENTO, POIS ESTE CABE SOMENTE AO MÉDICO ASSISTENTE DO PACIENTE SEGURADO, CONHECEDOR DAS PECULIARIDADES DE SEU QUADRO CLÍNICO. 5. NESTAS CIRCUNSTÂNCIAS, HAVENDO LAUDO MÉDICO QUE DEMONSTRA A NECESSIDADE DO TRATAMENTO DOMICILIAR COM O MEDICAMENTO POSTULADO NA EXORDIAL (ENOXAPARINA), TEM-SE COMO DEVIDO O FORNECIMENTO DA ALUDIDA MEDICAÇÃO, SENDO IRRELEVANTE, NO CASO, O LOCAL ONDE SERÁ MINISTRADO O FÁRMACO. 6. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS, EM ATENÇÃO AO PRECONIZADO PELO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50019545120218210017, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 25-05-2022)

APELAÇÕES CÍVEIS. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TROMBOFILIA. FORNECIMENTO DO FÁRMACO ENOXAPARINA. DEVER DE COBERTURA VERIFICADO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PLEITO INDENIZATÓRIO. INTEPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA EXORDIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO. 1. INCIDE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE, SALVO OS ADMINISTRADOS POR ENTIDADES DE AUTOGESTÃO, CONSOANTE DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 3º, §2º, BEM COMO PELO QUE DISPÕE A SÚMULA Nº 608 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O ARTIGO 35 DA LEI Nº 9.656/1998. 2. AS COBERTURAS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS POR PLANOS DE SAÚDE SE SUJEITAM A UM ROL MÍNIMO EDITADO PELA ANS, O QUAL NÃO PODE PREVER AS HIPÓTESES DO ART. 10 DA LEI Nº 9.656/98 E NÃO PODE EXCLUIR OU MITIGAR AS HIPÓTESES DO ART. 12 DA MESMA LEI. NÃO OBSTANTE, EVIDENTEMENTE QUE OS CONTRATOS FIRMADOS PODEM ALARGAR O ESPECTRO MÍNIMO DE COBERTURA, INCLUSIVE COBRINDO AS HIPÓTESES DO CITADO ART. 10. 3. NO PONTO, CUMPRE DESTACAR QUE, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA C. CÂMARA CÍVEL, O ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE PUBLICADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR É TÃO SOMENTE REFERÊNCIA BÁSICA DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS NOS PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE, NÃO POSSUINDO CARÁTER TAXATIVO. 4. RESSALTA-SE, OUTROSSIM, QUE, TAMBÉM DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA C. CÂMARA CÍVEL, É FACULTADO AOS PLANOS DE SAÚDE ESTABELECEREM PARA QUAIS PATOLOGIAS IRÃO OFERECER COBERTURA; NO ENTANTO, NÃO PODEM LIMITAR O TRATAMENTO, POIS ESTE CABE SOMENTE AO MÉDICO ASSISTENTE DO PACIENTE SEGURADO, CONHECEDOR DAS PECULIARIDADES DE SEU QUADRO CLÍNICO. 5. NESTAS CIRCUNSTÂNCIAS, HAVENDO LAUDO MÉDICO QUE DEMONSTRE A NECESSIDADE DO TRATAMENTO DOMICILIAR COM O MEDICAMENTO POSTULADO NA EXORDIAL (ENOXAPARINA), TEM-SE COMO DEVIDO O FORNECIMENTO DA ALUDIDA MEDICAÇÃO, SENDO IRRELEVANTE, NO CASO, O LOCAL ONDE SERÁ MINISTRADO O FÁRMACO. 6. POSSIBILIDADE DE EXAME DO PLEITO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS A PARTIR DE INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. A DESPEITO DE NÃO CONSTAR NA PARTE FINAL DESTINADA AOS REQUERIMENTOS DA EXORDIAL, OBSERVA-SE QUE CONSTA, DE FORMA CLARA, NA FUNDAMENTAÇÃO DA PEÇA VESTIBULAR, BEM COMO REFUTADO EXPRESSAMENTE EM CONTESTAÇÃO. 7. COM EFEITO, NÃO É QUALQUER DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE SERÁ CAPAZ DE ENSEJAR REPARAÇÃO, PORQUE É NECESSÁRIO ESTAREM PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL, QUAIS SEJAM: A CONDUTA CULPOSA, O NEXO CAUSAL E O DANO. 8. NO ENTANTO, EM SITUAÇÕES NAS QUAIS O DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO ATINGIR VALORES FUNDAMENTAIS PROTEGIDOS PELA CF/88, CAUSANDO, POR EXEMPLO, ABALO À MORAL, À PSIQUE, À SAÚDE DA PESSOA, FERINDO SUA IMAGEM OU PERSONALIDADE; EXTRAPOLANDO, PORTANTO, O MERO DISSABOR E A ESFERA DO DANO MATERIAL, A SOLUÇÃO É DIVERSA, SENDO CABÍVEL A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 9. NO CASO CONCRETO, AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE SUBJAZEM À LIDE E O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AO FEITO INDICAM QUE A NEGATIVA DE COBERTURA DO FÁRMACO POSTULADO ULTRAPASSOU O MERO DISSABOR, GERANDO EFETIVO ABALO PSICOLÓGICO À AUTORA DURANTE GRAVIDEZ DE RISCO. 10. ARBITRA-SE O QUANTUM INDENIZATÓRIO EM R$10.000,00, VISTO QUE ATENDE AOS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, BEM COMO AOS ELEMENTOS QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA QUANTIFICAÇÃO, TAIS COMO A GRAVIDADE DO FATO, A INTENSIDADE E DURAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS, A CONDIÇÃO ECONÔMICA E O DÚPLICE CARÁTER (COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO) DA REPARAÇÃO. 11. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS, EM ATENÇÃO AO PRECONIZADO PELO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELO DA RÉ DESPROVIDO. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA EM PARTE. (Apelação Cível, Nº 50024432520208210017, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 27-04-2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPÊ-SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PONATINIB (ICLUSIG®) PARA O TRATAMENTO DE CÂNCER. Fornecimento de medicamento fora dos protocolos. A circunstância de não existir previsão de cobertura no regulamento do IPERGS não é motivo suficiente para o indeferimento do pedido. Conforme dispõe o art. 4º da Lei Complementar 15.145/08, integram o Plano IPE-SAÚDE os atendimentos médicos, hospitalares, ambulatoriais, laboratoriais, bem como atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos devidos aos usuários. Em que pese as disposições do parágrafo primeiro do artigo supramencionado, tem-se que a ausência de previsão no Protocolo Oncológico não deve servir de obstáculo ao fornecimento do tratamento médico postulado. Hipótese dos autos em que restou comprovado através de relatório médico especializado a necessidade e a urgência do fornecimento do medicamento ora solicitado, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença que determinou a condenação da Autarquia para o fornecimento do tratamento para doença que acomete a parte autora, independentemente se os fármacos constam ou não em seus protocolos ou listas. Honorários advocatícios. Valor. Redução. A verba honorária sucumbencial deve ser fixada de acordo com os parâmetros definidos no art. 85, §8º, do CPC/15. A fixação dos honorários advocatícios, com base no §8º do artigo

supracitado, mostra-se plenamente adequada, notadamente porque a saúde tem valor inestimável, devendo ser fixada por apreciação equitativa do juiz. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70084415876, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 26-08-2020)

No mais, acerca da alegação defensiva da taxatividade do rol de procedimentos da ANS, tem-se que o rol da Agência Nacional de Saúde é meramente exemplificativo*:*

*PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. MENOR ACOMETIDO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO, HIPERATIVIDADE E DIFICULDADE DE APRENDIZADO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA COM TESTE WISC. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA MÍNIMA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.2. A falta de previsão de material solicitado por médico, ou mesmo procedimento, no rol da ANS, não representa a exclusão tácita da cobertura contratual.3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do AgInt no REsp nº 1.829.583/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado aos 22/ 6/2020, **reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos.**4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1876786/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe **22/10/2020**) (Grifei)*

Nesse sentido ainda cito:

*APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PREFACIAIS RECURSAIS REJEITADAS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PARALISIA CEREBRAL. TRATAMENTO FISIOTERÁPICO PELO MÉTODOS BOBATH E PROTOCOLO PEDIASUIT, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL E TREINADOR DE MARCHA. COBERTURA DEVIDA. 1. É DE SER AFASTADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, PORQUANTO O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA E A ELE INCUMBE DECIDIR SOBRE A NECESSIDADE OU NÃO DE SUA PRODUÇÃO (ART. 370 DO CPC). ASSIM, PODE INDEFERIR A PRODUÇÃO DE PROVA SE ENTENDER PRESCINDÍVEL PARA O SEU CONVENCIMENTO, EM RAZÃO DE EXISTIREM OUTRAS PROVAS SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO DO MÉRITO. 2. NO QUE CONCERNE À PREFACIAL DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, TEM-SE QUE NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO, DEVENDO SER MANTIDO O VALOR DA CAUSA FIXADO EM SENTENÇA, EQUIVALENTE A UMA PRESTAÇÃO ANUAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 292, § 2º, DO CPC 3. NO MÉRITO, CUMPRE REFERIR QUE NÃO HÁ MAIS DÚVIDA QUANTO À APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AOS CONTRATOS DE SEGUROS E DE PLANOS DE SAÚDE, EXCETO NOS PLANOS DENOMINADOS DE AUTOGESTÃO, NOS TERMOS DA SÚMULA 608 DO E.STJ. NÃO OBSTANTE, TAL EXCLUSÃO DE INCIDÊNCIA NÃO AFASTA A APLICAÇÃO DOS DITAMES GERAIS DO DIREITO CONTRATUAL, PRINCIPALMENTE A INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO ADERENTE, A NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ (SUBJETIVA E OBJETIVA) E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. 4. AS COBERTURAS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS POR PLANOS DE SAÚDE SE SUJEITAM A UM ROL MÍNIMO EDITADO PELA ANS, O QUAL NÃO PODE PREVER AS HIPÓTESES DO ART. 10 DA LEI Nº 9.656/98 E TAMBÉM NÃO PODE EXCLUIR OU MITIGAR AS HIPÓTESES DO ART. 12 DA MESMA LEI. NÃO OBSTANTE, EVIDENTEMENTE QUE OS CONTRATOS FIRMADOS PODEM ALARGAR O ESPECTRO MÍNIMO DE COBERTURA, INCLUSIVE COBRINDO AS HIPÓTESES DO CITADO ART. 10. 5. NO PONTO, CUMPRE DESTACAR QUE, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA C. CÂMARA CÍVEL, **O ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE PUBLICADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR É TÃO SOMENTE REFERÊNCIA BÁSICA DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS NOS PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NÃO POSSUINDO CARÁTER TAXATIVO.** 6. RESSALTE-SE, OUTROSSIM, QUE, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA C. CÂMARA CÍVEL, É FACULTADO AOS PLANOS DE SAÚDE ESTABELECEREM PARA QUAIS PATOLOGIAS IRÃO OFERECER COBERTURA; NO ENTANTO, NÃO PODEM LIMITAR O TRATAMENTO, POIS ESTE CABE SOMENTE AO MÉDICO ASSISTENTE DO PACIENTE SEGURADO, CONHECEDOR DAS PECULIARIDADES DE SEU QUADRO CLÍNICO. 7. EM FACE DE TAIS CONSIDERAÇÕES, SENDO INCONTROVERSA A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES, BEM COMO HAVENDO LAUDO MÉDICO QUE DEMONSTRA A NECESSIDADE DO TRATAMENTOS POSTULADOS NA EXORDIAL, TEM-SE COMO DEVIDO O FORNECIMENTO DOS ALUDIDOS TRATAMENTOS, SOBRETUDO PORQUANTO CONCERNENTE À PATOLOGIA INCONTROVERSAMENTE COBERTA PELO PLANO DE SAÚDE (PARALISIA CEREBRAL, CID G80). DESTARTE, AFIGURA-SE IMPERIOSO O RECONHECIMENTO DO DEVER DE COBERTURA. 8. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS, EM ATENÇÃO AO PRECONIZADO PELO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELO DESPROVIDO. (TJRS, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014422-66.2019.8.21.0001, 5ª Câmara Cível, Desembargadora LUSMARY FATIMA TURELLY DA SILVA, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 28/10/2020) (Grifei)*

*APELAÇÃO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO CAPECITABINA. USO DOMICILIAR. TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO. ABUSIVIDADE. Incide o Código de Defesa do Consumidor à Espécie (Súmula nº 608 do Stj), por se Tratar de Típico Contrato de Adesão, o Que Possibilita A decretação da Nulidade das Cláusulas Que "Estabeleçam Obrigações Consideradas Iníquas, Abusivas, Que Coloquem o Consumidor em Desvantagem Exagerada, Ou Seja, Incompatíveis Com a Boa-fé Ou a Equidade", Bem Como Que as Cláusulas Contratuais Devem Ser Interpretadas de Maneira Mais Favorável ao Consumidor, Nos Termos do Artigos 6º, v, 47 e 51, iv, do Referido Diploma. "A exclusão de cobertura de determinado procedimento médico ou hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato" (REsp 183.719/SP). O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, bem como bem como o número de sessões, pois tal incumbência é do profissional que assiste o paciente, a quem compete avaliar os riscos e benefícios do tratamento e indicar a alternativa mais adequada (STJ, Resp nº 668.216-SP, j. 15.03.2007). **O rol de procedimentos previsto nas normas da ANS não é taxativo, traduzindo somente um referencial de coberturas básicas para os planos de saúde.** Os planos de saúde devem incluir em sua coberturas os medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso. Art. 21, XI, da RN 428/2017, da ANS. No caso dos autos, o laudo e a prescrição médica acostados à inicial atestam que a autora tem diagnóstico de Neoplasia maligna da mama e necessita do tratamento com o medicamento Capecitabina. Sentença mantida. Fixação de honorários recursais. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME. (TJRS, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011376-69.2019.8.21.0001, 6ª Câmara Cível, Desembargadora DENISE OLIVEIRA CEZAR, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 22/10/2020) (Grifei)*

*APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO COM MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR. REALIZAÇÃO DE EXAME. COBERTURA DEVIDA. 1. OS PLANOS OU SEGUROS DE SAÚDE ESTÃO SUBMETIDOS ÀS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ENQUANTO RELAÇÃO DE CONSUMO ATINENTE AO MERCADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. ISTO É O QUE SE EXTRAI DA INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 35 DA LEI 9.656/98. SÚMULA N. 469 DO STJ. 2. APLICÁVEIS AO CASO EM EXAME AS EXIGÊNCIAS MÍNIMAS PREVISTAS NO PLANO-REFERÊNCIA DE QUE TRATA OS ARTIGOS 10 E 12 DA LEGISLAÇÃO DOS PLANOS DE SAÚDE. 3. **O ROL DE PROCEDIMENTOS PUBLICADO PELA ANS CONSTITUI APENAS UMA REFERÊNCIA BÁSICA***

DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS NOS PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NÃO SENDO TAXATIVO, DE MODO QUE DEVE SER OBSERVADA A PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE DA PARTE AUTORA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. *4. ADEMAIS, O QUE IMPORTA PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO É A EXISTÊNCIA DE COBERTURA PARA A PATOLOGIA APRESENTADA, E NÃO A FORMA COMO O TRATAMENTO SERÁ REALIZADO. 5. DESSA FORMA, SE HÁ PREVISÃO DE COBERTURA PARA A DOENÇA APRESENTADA PELO BENEFICIÁRIO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL PARA O TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. 6. NÃO CABE À DEMANDADA DETERMINAR O TIPO DE TRATAMENTO QUE SERÁ REALIZADO PELA PARTE AUTORA, UMA VEZ QUE ESTA DECISÃO CABE AO MÉDICO QUE A ACOMPANHA, QUE NO CASO INDICOU O TRATAMENTO COM O MEDICAMENTO REFERIDO POR SER O MAIS ADEQUADO ÀS CONDIÇÕES DO DEMANDANTE. 7. ASSIM, DESCABIDA A NEGATIVA SECURITÁRIA POR PARTE DA DEMANDADA EM FUNÇÃO DE O TRATAMENTO PODER SER MINISTRADO EM DOMICÍLIO, POIS O QUE IMPORTA PARA SOLUÇÃO DO LITÍGIO É A EXISTÊNCIA DE COBERTURA PARA A DOENÇA APRESENTADA, INDEPENDENTEMENTE DO LOCAL EM QUE ESTE DEVERÁ SER MINISTRADO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. 8. OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVERÃO SER MAJORADOS QUANDO A PARTE RECORRENTE NÃO LOGRAR ÊXITO NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO, INDEPENDENTE DE PEDIDO A ESSE RESPEITO, DEVIDO AO TRABALHO ADICIONAL NESTA INSTÂNCIA, DE ACORDO COM OS LIMITES FIXADOS EM LEI. INTELIGÊNCIA DO ART. 85 E SEUS PARÁGRAFOS DO NOVEL CPC. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. (TJRS, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003226-37.2019.8.21.5001, 5ª Câmara Cível, Desembargador JORGE LUIZ LOPES DO CANTO, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 30/09/2020) (Grifei)*

AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. TROMBOFILIA. GESTANTE. TRATAMENTO DOMICILIAR. MEDICAMENTO ENOXOPARINA. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDIMENSIONAMENTO. I. NO CASO, A AUTORA É PORTADORA DE TROMBOFILIA, ENCONTRANDO-SE EM ESTADO GESTACIONAL, COM HISTÓRICO PRÉVIO DE PERDAS DE FETOS, RAZÃO PELA QUAL NECESSITA DO USO DIÁRIO DO MEDICAMENTO ENOXOPARINA 40MG, CUJA COBERTURA PARA O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR FOI NEGADA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. II. CONTUDO, OS CONTRATOS DE PLANOS DE SAÚDE ESTÃO SUBMETIDOS ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, NA FORMA DA SÚMULA 608, DO STJ, DEVENDO SER INTERPRETADOS DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL À PARTE MAIS FRACA NESTA RELAÇÃO. DE OUTRO LADO, OS PLANOS DE SAÚDE APENAS PODEM ESTABELECER PARA QUAIS DOENÇAS OFERECERÃO COBERTURA, NÃO LHES CABENDO LIMITAR O TIPO DE TRATAMENTO QUE SERÁ PRESCRITO, ***AINDA QUE NÃO ESTEJA PREVISTO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS, O QUAL É MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO, CONFORME ENTENDIMENTO DO EGRÉGIO STJ****, OU NÃO PREENCHIDA A DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO, INCUMBÊNCIA ESSA QUE PERTENCE AO PROFISSIONAL DA MEDICINA QUE ASSISTE O PACIENTE. III. NESSA LINHA, CONFORME ENTENDIMENTO DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O LOCAL DA ADMINISTRAÇÃO DO MEDICAMENTO É IRRELEVANTE PARA DEFINIR O DEVER DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. EM OUTRAS PALAVRAS, SE HÁ COBERTURA PARA A DOENÇA, DEVE SER FORNECIDO O MEDICAMENTO MINISTRADO PELO MÉDICO, MESMO QUE PARA USO DOMICILIAR. ALÉM DO MAIS, DEVE SER PRIORIZADO O DIREITO À SAÚDE E À VIDA EM RELAÇÃO AO DIREITO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 47 E 51, IV, § 1°, II, DO CDC. IV. PORTANTO, MOSTRA-SE ABUSIVA A NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO COM O MEDICAMENTO EM QUESTÃO. V. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA, CONSIDERANDO O INTEGRAL DECAIMENTO DA RÉ EM SUAS PRETENSÕES. APELAÇÃO PROVIDA. (TJRS, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009456-33.2019.8.21.0010, 5ª Câmara Cível, Desembargador JORGE ANDRE PEREIRA GAILHARD, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 26/08/2020) (Grifei)*

Não bastasse a argumentação supra, observa-se que, apesar de o medicamento aqui em discussão não constar no rol da ANS, o mesmo é amplamente recomendado em consultas realizadas junto ao e-Natjus (portal eletrônico do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário), em casos idênticos ao aqui em discussão (pesquisa disponível em **https://www.cnj.jus.br/e-natjus/pesquisaPublica.php**)

Destarte, devida a cobertura do tratamento pela ré.

DIANTE DO EXPOSTO, e, para os fins do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo **PROCEDENTE** a ***AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - COM PEDIDO DE TUTELAANTECIPADA*** ajuizada por **JAQUELINE GIEBMEIER** em face de **UNIMED VALE DO TAQUARI E RIO PARDO** para, confirmando a antecipação de tutela já deferida, **CONDENAR a parte ré no fornecimento da medicação ICLUSIG (Ponatinib) 15mg** conforme orientação médica, sendo necessárias 3 (três) caixas mensais, para o correto enfrentamento da doença de que a parte autora é portadora.

Outrossim, arcará a ré com o pagamento das despesas processuais, bem como honorários advocatícios ao procurador da parte autora, cujo montante, em atenção ao artigo 85, do CPC e Tema Repetitivo 1076/STJ (Resp 1.850.512, Resp 1.877.883, Resp 1.906.623 e Resp 1.906.618), fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa.

Documento assinado eletronicamente por **CARMEN LUIZA ROSA CONSTANTE, Juíza de Direito**, em 26/10/2022, às 16:28:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10026962254v8** e o código CRC **61d40259**.

---

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. ↩